

한빛대학교종합병원	응급실 초진 및 처치기록	문서번호 ER-260804-0173
HANBIT UNIVERSITY GENERAL HOSPITAL	Emergency Department Initial Assessment & Treatment Record	발행구분: 합성/테스트

환자성명	이도현 (가상)	성별/나이	남 / 58세	등록번호	ER-260804-0173
내원일시	2026-08-04 18:42	도착수단	자가용	보호자	배우자 동행
주소	부산광역시 해운대구 가사로 00	연락처	010-0000-1730	보험	건강보험(가상)

1. 중증도 분류 및 활력징후

KTAS	3 (응급)	의식	Alert	통증점수	NRS 7/10
혈압	168/96 mmHg	맥박	104 /min	호흡	22 /min
체온	37.2 °C	SpO ₂	96% (Room air)	혈당	132 mg/dL

2. 주호소 및 현병력

주호소	흉통 및 식은땀 - 내원 약 1시간 20분 전 시작
현병력	저녁 식사 후 소파에 앉아 있던 중 흉골 뒤쪽의 압박감이 발생하였다. 통증은 왼쪽 어깨와 턱으로 퍼졌으며, 휴식 후에도 호전되지 않았다. 오심과 식은 땀이 동반되었다. 실신은 없었고, 호흡곤란은 경도였다.
과거력	고혈압 8년, 이상지질혈증 3년. 당뇨병·뇌졸중 병력 없음. 5년 전 위내시경상 미란성 위염.
복용약	아로리핀 5 mg 1일 1회, 로수바스타틴 10 mg 1일 1회. 최근 2주간 간헐적으로 복용 누락.
알레르기	페니실린 투여 후 발진 병력(정확한 약명 불명). 음식 알레르기 없음.
사회력	흡연 20갑년, 현재 하루 5개비. 음주 주 2회 소주 3~4잔.

3. 신체검진

전신	급성 병색, 불안해 보이나 지남력 유지
심혈관	빈맥, 규칙적 리듬. 뚜렷한 심잡음 없음. 말초부종 없음.
호흡기	양측 호흡음 대칭, 수포음 천명음 없음.
복부	편평하고 부드러움. 압통·반발통 없음.
신경계	동공 대칭, 사지 근력 5/5, 국소 신경학적 결손 없음.

4. 검사 및 처치

시간	구분	내용	결과/반응
18:47	검사	12유도 심전도	V2-V4 ST분절 1-2 mm 상승 의심, 재검 예정
18:49	투약	Aspirin 300 mg PO (씹어서 복용)	구토 없이 복용 완료
18:52	처치	산소 2 L/min nasal cannula	SpO ₂ 98% 유지
18:55	검사	CBC, 전해질, BUN/Cr, Troponin-I, CK-MB, PT/aPTT	채혈 완료
19:01	투약	Nitroglycerin 0.4 mg SL 1회	통증 NRS 7 → 4, 혈압 148/88
19:07	검사	Portable chest AP	급성 폐부종 또는 기흉 소견 없음
19:12	협진	순환기내과 당직 전문의 호출	응급 관상동맥조영술 준비 지시

5. 임상판단 및 disposition

추정진단	1) 급성 관상동맥증후군 - 전벽 STEMI 의심 2) 조절되지 않는 고혈압 3) 흡연
계획	심전도 10분 이내 재검, 심근효소 추적검사, 항혈소판제 및 항응고제 투여 검토, 순환기내과 협진 후 심혈관조영실 이동. 페니실린 알레르기 병력은 전 산 경고 등록.
처리결과	2026-08-04 19:28 심혈관조영실로 이동. 이동 당시 의식 명료, 흉통 NRS 3, 혈압 142/84 mmHg.

작성자: 응급의학과 전공의 김하늘 (가상)	확인자: 응급의학과 전문의 박준서 (가상)
-------------------------	-------------------------